

Fecha Última Actualización: 29-01-2023 10:01:58

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Carlos Alberto Perez Alvarado
Edad : 36a 4m 18d
Dirección : Diego Portales 05960 Dpto. 209

Rut : 26.070.277-7
Fecha Nacto: 11/09/1986
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2301683
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9999 9999

N° Epicrisis
339441

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 24/01/2023 21:07

Días Estadía: 5

Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Egreso : 29/01/2023 10:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Herida por arma de fuego.

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Laparotomía Exploradora, C/S Liberación De Adherencias, C/S Drenaje, C/S Biopsias Como Proc. Aut. O Como Resultado De Una Herida Penetrante Abdominal No Complicada O De Un Hemoperitoneo Postoperatorio O Como Tratamiento De Una Peritonitis (Laparostomía .. - 24/01/2023 00:00 - Gabriel Escalona Vivas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes:

-Mórbidos: No conocidos.

-Quirúrgicos: (-).

-Medicamentos: No conocidos.

-Alergias: (-).

-Hábitos: TBQ (-), OH (+) diario, Drogas (-).

Historia clínica:

Paciente ingresa el 24/01 a unidad de reanimación SU CASR con herida de arma de fuego en abdomen, con evidente aumento de volumen escrotal. Se administran 500 cc de SF + 1 gr de ácido tranexámico + 2 unidades de GR. Posterior traslado a pabellón de urgencia donde se realiza laparotomía exploradora, evidenciado gran hematoma y lesión vascular. Sangrado estimado 5.000 mL, activándose transfusión masiva (8 U GR + 6 U criopecitado + 6 U de PFC + 6 U PQT) quedando con balance (+) 1.380. Requerimientos de NAD hasta 0.3 ug/kg/min. Se realizó ligadura de vena femoral derecha, explorándose cavidad peritoneal en sus 4 cuadrantes sin encontrar otras lesiones. A su ingreso a UCI con DVA ya suspendidas, frío a distal con llene capilar > 5 segundos, sedado en SAS 1 en VMI.

Durante hospitalización en UCI evoluciona favorablemente, con permeabilidad vascular a distal objetivada con doppler, sin requerimientos de DVA, con weaning exitoso a las 48 horas, débito urinario adecuado.

Es trasladado a sala estable, con hemodinamia autosostenida, afebril, alimentándose con buena tolerancia oral, sin dolor, sólo con edema en extremidad y escroto.

Actualmente en buenas condiciones generales, afebril, con hemodinamia estable, sin apremio ventilatorio ni requerimiento de oxígeno, con buena tolerancia oral, con diuresis espontánea sin sonda, sin dolor, deambulando con ayuda, sin otras molestias, en condiciones de alta hospitalaria y control ambulatorio.

Diagnóstico de Egreso

HERIDA DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS -
TRAUMATISMO DE LA VENA FEMORAL A NIVEL DE LA CADERA Y DEL MUSLO - ligadura de vena femoral común
AGRESIÓN CON DISPARO DE OTRAS ARMAS DE FUEGO, Y DE LAS NO ESPECIFICADAS, OCURRIDA EN OTRO

Fecha Epicrisis : 29/01/2023 10:01

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 29-01-2023 10:01:58

Página 2 de 2

LUGAR ESPECIFICADO - Herida por arma de fuego en abdomen

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en buenas condiciones generales, afebril, con hemodinamia estable, sin apremio ventilatorio ni requerimiento de oxígeno, con buena tolerancia oral, con diuresis espontánea sin sonda, sin dolor, deambulando con ayuda, sin otras molestias, en condiciones de alta hospitalaria y control ambulatorio.

Plan Post Alta

Reposo relativo, levantarse con ayuda, por 3 semanas.

Uso de media compresiva, anti embólica en extremidad inferior derecha.

Uso de suspensor escrotal.

Mantener extremidad en alto.

No mojar heridas.

Curaciones día por medio en CDT, pasillo 2.

Paracetamol 500 mg VO, 2 comp cada 8 horas por 7 días.

Ketoprofeno 50 mg VO, 1 comp cada 8 horas por 5 días.

Amoxicilina/Ac. clavulánico 500/125 mg VO, 1 comp cada 8 horas por 10 días.

Control el jueves 2 de febrero en CDT, pasillo 11, con Dr. Stefano Cacciuttolo, a las 12:00.

Control en urgencias en caso de dolor intenso que no ceda con analgesia, fiebre, vómitos, sangrado de heridas, o en caso es estimar necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Común

Medicamentos : Paracetamol 500mg 2 Comp Cada 8 Horas Por 7 Días.
Ketoprofeno 50mg 1 Comp Cada 8 Horas Por 5 Días.
Amoxicilina/Ac.Clavulanico 500/125 Mg Cmp 1 Comp Cada 8 Horas Por 10 Días.

Controles

INTERNO


Stefano Bec Cacciuttolo Darrigran
Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)